SDD 131 - Sujet n°1

Spécialité : Gériatrie

Date : 01/11/2024
Auteur : Anne-Sophie PLATEK (DES Médecine générale, 2024)
Relecteur(s) : Eloïse FRANCQ (DES Gériatrie, 2020), Clément FILLIOL (DES RAI, 2022)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de la prise en charge
Item(s) en lien avec la station	132 : troubles cognitifs du sujet âgé
Situation(s) de départ en lien avec la station	131 : troubles de mémoire/déclin cognitif
Matériel nécessaire à la station	iPad examinateur, feuille de brouillon, stylo candidat
Contexte de la station	Caractériser une plainte mnésique

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne de gériatrie.

Vous recevez le patient M Perdu, âgé de 70 ans en consultation mémoire qui vous consulte seul à la demande de son médecin traitant.
Le bilan sanguin déjà réalisé par son médecin traitant (NFS, CRP, ionogramme sanguin, calcémie, albuminémie, TSH, glycémie à jeun, fonction rénale) était sans particularités.
Paramètres : T° 37,1 °C, FC 85/min, PA 132/85 mmHg

Consignes :

Vous devez, en 8 minutes, incluant la lecture de ces consignes :

- Réaliser un interrogatoire ciblé par rapport à la plainte du patient
- Expliquer les examens complémentaires envisagés a priori

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'examen clinique
- Rédiger d'ordonnance
- Annoncer de diagnostic

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec PS.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
1.	Recherche les antécédents personnels ET familiaux du patient	1 pt	☐
2.	Recherche une perte d'autonomie ou d'indépendance fonctionnelle sur les IADL : courses, cuisine, lessive, ménage, budget, téléphone, médicaments, conduite (cite au moins 3 éléments)	1 pt	☐
3.	Recherche perte d'autonomie sur les ADL : hygiène, habillage, toilettes, transfert, continence, repas (cite au moins 3 éléments)	1 pt	☐
4.	Se renseigne sur le mode de vie : lieu de vie, famille, aides à domicile, allergies, vaccins (recherche au moins 2 éléments)	1 pt	☐
5.	Caractérise la plainte : évolution progressive, anosognosie, oublis à mesure (recherche au moins 2 éléments)	1 pt	☐
6.	Élimine un syndrome confusionnel : désorientation temporo-spatiale, rupture brutale avec l'état antérieur, fluctuation des symptômes, hypovigilance diurne (recherche au moins 2 éléments)	1 pt	☐
7.	Recherche la prise de toxiques : tabac ET alcool	1 pt	☐
8.	Recherche la prise de traitements dont l'introduction de traitements et la prise de psychotropes	1 pt	☐
9.	Recherche des signes orientant vers un épisode dépressif caractérisé : anhédonie, tristesse, aboulie, modification de l'appétit, insomnie avec réveils matinaux (recherche au moins 2 éléments)	1 pt	☐
10.	Recherche des signes de maladie à corps de Lewy : cauchemars, trouble du comportement en sommeil paradoxal, hallucinations visuelles/apraxie visuelle, fluctuation de la vigilance (recherche au moins 2 éléments)	1 pt	☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

11.	Propose de réaliser des tests neuropsychologiques dont le MMSE, le test de l'horloge, le test des 5 mots et la BREF (cite au moins 1 test)	1 pt	☐
12.	Propose de réaliser une IRM cérébrale	1 pt	☐
13.	Prévoit une consultation avec les résultats des examens	1 pt	☐

Communications et attitudes

14.

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

15.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

16.	**5. COMMUNICATION NON VERBALE**

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

17.	**12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)**

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	**17 points**

Éléments de rétroaction :

Dans cette station, le patient présente une probable maladie d'Alzheimer à un stade pré-démentiel (plainte mnésique avec oublis à mesure qu'il minimise (= anosognosie), autonomie préservée, sans autres troubles de l'attention, des fonctions instrumentales et exécutives et du comportement).

Il faut éliminer d'autres diagnostics différentiels tels qu'un syndrome confusionnel, un épisode dépressif caractérisé, une cause iatrogénique, la maladie à Corps de Lewy …

Vous n'avez pas encore réalisé d'examen clinique et que ces éléments pourraient orienter votre bilan étiologique mais certains éléments sont communs dans la recherche de troubles neurocognitifs.

*En 1ère intention, on peut réaliser plusieurs tests neuropsychologiques tels que le MMSE, la BREF, le test de l'horloge pour s'orienter, ainsi qu'une **IRM cérébrale** +++ à la recherche notamment d'une atrophie hippocampique dans le cadre de la maladie d'Alzheimer (en plus du bilan biologique déjà réalisé).*

Le patient devra être revu avec les résultats d'IRM mais également pour organiser la suite de la prise en charge, évaluer la thymie (toute annonce de diagnostic n'est pas anodine) et la clinique actuelle.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Contexte :

Vous êtes interne de gériatrie.

Vous recevez le patient M Perdu, âgé de 70 ans en consultation mémoire qui vous consulte seul à la demande de son médecin traitant.

Le bilan sanguin déjà réalisé par son médecin traitant (NFS, CRP, ionogramme sanguin, calcémie, albuminémie, TSH, glycémie à jeun, fonction rénale) était sans particularités.

Paramètres : T° 37,1 °C, FC 85/min, PA 132/85 mmHg

Consignes :

Vous devez, en 8 minutes, incluant la lecture de ces consignes :

- Réaliser un interrogatoire ciblé par rapport à la plainte du patient
- Expliquer les examens complémentaires envisagés a priori

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'examen clinique
- Rédiger d'ordonnance
- Annoncer de diagnostic

Plan de la station ECOS :

Patient sur chaise en face du candidat de l'autre côté de la table

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

« Bonjour Docteur, je viens vous voir car ma femme dit que je perds la tête ».

Identité du patient :

M. PERDU Pierre, 70 ans, 170 cm, 80 kg (IMC 27,7 kg/m2)

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales

Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.

Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

Mode de vie :

- Ancien cuisinier à la retraite, marié, 3 enfants et 2 petits-enfants.
- Vit avec sa femme Louise et son chien Billy dans une maison en banlieue parisienne. Autonome, pas d'aide à domicile, pas de protection juridique.
- Boit 1 verre de vin rouge le midi, pas de tabagisme, pas d'allergies.

Comportement global :

Sympathique mais un peu inquiet. Il ne comprend pas pourquoi sa femme lui a demandé de consulter (anosognosique), même s'il oublie certains rendez-vous, ce qu'il a mangé au dernier repas et la date d'anniversaire de sa petite-fille.

Antécédents personnels :

HTA traitée, pas d'autres antécédents

Antécédents familiaux :

Grand-mère maternelle « perdait la tête à la fin de sa vie » (non diagnostiquée)

Médicaments :

Bithérapie ARA2 + diurétique thiazidique. Bonne observance, pas de changement de traitement récent.

Symptômes positifs :

- Evolution progressive : depuis 1 an, sa femme dit qu'il oublie des choses (rendez-vous médicaux, repas mangé la veille, film regardé …). Depuis 6 mois, elle le dit de plus en plus souvent et la semaine dernière « j'ai oublié la date d'anniversaire de ma petite-fille, vous vous rendez compte Docteur ! »
- Pas d'aggravation brutale, pas d'argument pour un syndrome confusionnel.
- Pas d'anxiété, pas d'argument pour un épisode dépressif caractérisé (pas d'anhédonie …), pas de troubles du sommeil.
- Pas d'arguments pour une maladie à Corps de Lewy : pas de cauchemars, pas de coups donnés à sa femme (ils dorment ensemble), pas d'HAV.
- Pas de chutes, pas de troubles de la marche, ni de troubles sphinctériens.
- Autonomie préservée : ADL 6 (s'habille seul, continent, va aux toilettes seul, mange sans aide, marche sans aide technique, fait sa toilette seul), IADL 4 (gère les papiers du couple, utilise son téléphone pour appeler ses enfants et ses copains de la pétanque, utilise sa voiture, prend bien ses

Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

médicaments seul).
- Pas d'aphasie, pas d'apraxie.
- Pas de modification récente du poids ou de l'appétit.

Constantes :

Constantes : T° 37,1 °C, FC 85/min, PA 132/85 mmHg

Donnée complémentaire :

0

Questions de relance :

Si pas d'examen complémentaire énoncé au bout de la **6ème minute** : « Est-ce que les examens que j'ai fait avec mon médecin suffisent ou je dois faire d'autres examens Docteur ? »

Si des examens complémentaires sont prescrits mais pas de suivi prévu au bout de la **6ème minute** : «Est-ce qu'il faut que je montre les résultats à mon médecin traitant ?»

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Une table avec 2 chaises, patient simulé sur une chaise et le candidat sur l'autre chaise de l'autre côté du bureau.

Matériel nécessaire à la station :

- *IPAD pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction, même partielle, et toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES Anesthésie-Réanimation, Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES Médecine Interne, Paris), Clément FILLIOL (VP ECOS, DES Radiologie, Lyon) et Alexandre DEGACHI (Président, ancien DES Médecine Interne, Paris)